テスト用架空事例

認定結果(テスト用設定)

要介護度	要介護1
認定日	令和8年9月30日(テスト用)
認定の有効期間	令和8年10月1日～令和9年9月30日(12か月)(テスト用)

認 定 調 査 票 (概 況 調 査)

Ⅰ 調査実施者(記入者)

実施日時	令和8年9月9日 (テスト用)
実施場所	自宅
記入者氏名・所属	＊＊＊＊(テスト用)

Ⅱ 調査対象者

過去の認定	更新申請(前回:要介護1)		
対象者氏名	岡本 輝夫 (おかもと てるお)	性別	男
生年月日	昭和25年(1950年)3月8日	年齢	76歳
現住所	○○県○○市＊＊＊＊(テスト用)		
家族等連絡先	＊＊＊＊(テスト用)		

Ⅲ 現在受けているサービスの状況

介護給付 訪問看護(週1回・体重と浮腫、服薬の確認)、訪問介護(生活援助・週2回、入浴時の身体介護・週2回)。その他 配食サービス(週5回)。

Ⅳ 置かれている環境等(調査対象者の家族状況、調査対象者の居住環境、日常的に使用する機器・器械の有無等)

家族状況	独居(妻とは5年前に死別)。長女(48歳)は県外(新幹線で2時間)に住み、月1回帰省し、毎日電話で様子を確認している。
居住環境	2階建てアパートの1階(賃貸)。段差は少ない。浴室は狭く、手すりはない。
使用している機器等	体重計、血圧計(毎日自分で測定し記録)。
生活歴	機械部品の工場に定年まで勤めた。将棋が趣味で、元気なころは地域の将棋クラブに通っていた。
本人・家族の主訴	本人:「入院はもうこりごり。できるだけこの部屋で暮らしたい。」 長女:「遠くて急に悪くなっても行けない。むくみや体重の変化に早く気づいてほしい。」

認定調査票(基本調査)

テスト用架空事例

該当する選択肢を〇で囲んでいます。

第1群 身体機能・起居動作	
1-1 麻痺等の有無 (複数選択可)	(ない) 左上肢　右上肢　左下肢　右下肢　その他(四肢の欠損)
1-2 拘縮の有無 (複数選択可)	(ない) 肩関節　股関節　膝関節　その他(四肢の欠損)
1-3 寝返り	(つかまらないでできる) 何かにつかまればできる　できない
1-4 起き上がり	(つかまらないでできる) 何かにつかまればできる　できない
1-5 座位保持	(できる) 自分の手で支えればできる　支えてもらえればできる　できない
1-6 両足での立位保持	(支えなしでできる) 何か支えがあればできる　できない
1-7 歩行	(つかまらないでできる) 何かにつかまればできる　できない
1-8 立ち上がり	(つかまらないでできる) 何かにつかまればできる　できない
1-9 片足での立位	支えなしでできる (何か支えがあればできる) できない
1-10 洗身	介助されていない (一部介助) 全介助　行っていない
1-11 つめ切り	(介助されていない) 一部介助　全介助
1-12 視力	(普通(日常生活に支障がない)) 約1m離れた視力確認表の図が見える 目の前に置いた視力確認表の図が見える　ほとんど見えない 見えているのか判断不能
1-13 聴力	(普通) 普通の声がやっと聞き取れる　かなり大きな声なら何とか聞き取れる ほとんど聞えない　聞えているのか判断不能
第2群 生活機能	
2-1 移乗	(介助されていない) 見守り等　一部介助　全介助
2-2 移動	(介助されていない) 見守り等　一部介助　全介助
2-3 えん下	(できる) 見守り等　できない
2-4 食事摂取	(介助されていない) 見守り等　一部介助　全介助
2-5 排尿	(介助されていない) 見守り等　一部介助　全介助
2-6 排便	(介助されていない) 見守り等　一部介助　全介助
2-7 口腔清潔	(介助されていない) 一部介助　全介助
2-8 洗顔	(介助されていない) 一部介助　全介助
2-9 整髪	(介助されていない) 一部介助　全介助
2-10 上衣の着脱	(介助されていない) 見守り等　一部介助　全介助
2-11 ズボン等の着脱	(介助されていない) 見守り等　一部介助　全介助
2-12 外出頻度	(週1回以上) 月1回以上　月1回未満
第3群 認知機能	
3-1 意思の伝達	(調査対象者が意思を他者に伝達できる) ときどき伝達できる ほとんど伝達できない　できない
3-2 毎日の日課を理解	(できる) できない
3-3 生年月日や年齢を言う	(できる) できない
3-4 短期記憶	(できる) できない
3-5 自分の名前を言う	(できる) できない
3-6 今の季節を理解する	(できる) できない
3-7 場所の理解	(できる) できない
3-8 徘徊	(ない) ときどきある　ある

3-9 外出すると戻れない	(ない)　ときどきある　ある　テスト用架空事例
第4群 精神・行動障害	
4-1 物を盗られたなどと被害的になる	(ない)　ときどきある　ある
4-2 作話	(ない)　ときどきある　ある
4-3 泣いたり、笑ったりして感情が不安定になる	(ない)　ときどきある　ある
4-4 昼夜の逆転がある	(ない)　ときどきある　ある
4-5 しつこく同じ話をする	(ない)　ときどきある　ある
4-6 大声をだす	(ない)　ときどきある　ある
4-7 介護に抵抗する	(ない)　ときどきある　ある
4-8 「家に帰る」等と言い落ち着きがない	(ない)　ときどきある　ある
4-9 一人で外に出たがり目が離せない	(ない)　ときどきある　ある
4-10 いろいろなものを集めたり、無断でもってくる	(ない)　ときどきある　ある
4-11 物を壊したり、衣類を破いたりする	(ない)　ときどきある　ある
4-12 ひどい物忘れ	(ない)　ときどきある　ある
4-13 意味もなく独り言や独り笑いをする	(ない)　ときどきある　ある
4-14 自分勝手に行動する	(ない)　ときどきある　ある
4-15 話がまとまらず、会話にならない	(ない)　ときどきある　ある
第5群 社会生活への適応	
5-1 薬の内服	(介助されていない)　一部介助　全介助
5-2 金銭の管理	(介助されていない)　一部介助　全介助
5-3 日常の意思決定	(できる(特別な場合でもできる))　特別な場合を除いてできる　日常的に困難　できない
5-4 集団への不適応	(ない)　ときどきある　ある
5-5 買い物	介助されていない　見守り等　(一部介助)　全介助
5-6 簡単な調理	介助されていない　見守り等　(一部介助)　全介助

その他 過去14日間に受けた特別な医療

□点滴の管理　□中心静脈栄養　□透析　□ストーマ(人工肛門)の処置　□酸素療法　□レスピレーター(人工呼吸器)
□気管切開の処置　□疼痛の看護　□経管栄養　□モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等)　□じょくそうの処置
□カテーテル(コンドームカテーテル、留置カテーテル、ウロストーマ等)

日常生活自立度

障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)	自立　J1　(J2)　A1　A2　B1　B2　C1　C2
認知症高齢者の日常生活自立度	(自立)　Ⅰ　Ⅱa　Ⅱb　Ⅲa　Ⅲb　Ⅳ　M

認定調査票(特記事項)

テスト用架空事例

第1群 身体機能・起居動作	1-7 平らな所は歩けるが、50m程度で息切れがして休む。坂や階段では息切れが強い。 1-10 入浴は息切れが強くなるため、訪問介護員が背中と足を洗う介助をしている。
第2群 生活機能	2-12 近所のコンビニや、月2回の受診(タクシー)に出かける。
第3群 認知機能	認知機能に問題はない。
第4群 精神・行動障害	特記すべき行動はない。
第5群 社会生活への適応	5-1 薬は自分で管理しているが、利尿薬の飲み忘れがあり、訪問看護師が週1回確認している。 5-5 重い物は持てないため、訪問介護員が買い物をしている。 5-6 調理は配食サービスが中心。簡単な汁物は自分で作る。 心不全の増悪で、この1年に3回入院した。状態が短期間に変わりやすく、体重・浮腫・息切れの観察が欠かせない。
特別な医療	該当なし。

主 治 医 意 見 書

テスト用架空事例

申請者	岡本 輝夫 (男・76歳) 医療機関名・医師氏名:＊＊＊＊(テスト用)

1. 傷病に関する意見

(1)診断名	発症年月日
1. 慢性心不全(NYHA Ⅲ度)	約5年前
2. 2型糖尿病	約20年前
(2)症状としての安定性	不安定
(3)経過及び治療内容	令和3年に心不全を発症。この1年で心不全の増悪により3回入院(直近は令和8年7月、2週間)。塩分・水分の摂り過ぎや服薬の飲み忘れで、短期間に体重が増え、息切れ・浮腫が悪化する。 投薬:利尿薬、β遮断薬、ACE阻害薬、経口血糖降下薬。

2. 特別な医療(過去14日間以内に受けた医療)

なし

3. 心身の状態に関する意見

(1)日常生活の自立度等	障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度):J2 認知症高齢者の日常生活自立度:自立
(2)認知症の中核症状	短期記憶:問題なし/日常の意思決定:自立/意思の伝達:伝えられる
(3)認知症の行動・心理症状	なし
(4)その他の精神・神経症状	なし
(5)身体の状態	利き腕:右/身長168cm・体重64kg(乾燥重量60kg)/両下腿の浮腫(軽度)/麻痺なし/褥瘡なし

4. 生活機能とサービスに関する意見

(1)移動	屋外歩行:自立(短い距離)/車いす:用いていない/歩行補助具:使用していない
(2)栄養・食生活	食事行為:自立/栄養状態:良好/留意点:塩分6g未満、水分制限(1日1.2L)、糖尿病食
(3)現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態とその対処方針	心不全の増悪(体重増加・浮腫・呼吸困難)、低血糖 → 毎日の体重測定、2日で2kg以上の増加は受診、服薬の確認
(4)サービス利用による生活機能の維持・改善の見通し	期待できる
(5)医学的管理の必要性	訪問看護(体重・浮腫・服薬の観察)
(6)サービス提供時における医学的観点からの留意事項	血圧・体重:毎日確認/運動:息切れが強いときは中止/入浴:長湯を避ける
(7)感染症の有無	なし

5. 特記すべき事項

症状は不安定で、短期間に心不全が増悪し入退院を繰り返している。独居で家族が遠方のため、訪問看護による継続的な観察と、異常時の早めの受診が必要。